

AFGSU 2

COURS DE RÉVISION 2026

Version couleur • support pédagogique synthétique

PROTÉGER

ÉVALUER

ALERTER

AGIR

SURVEILLER

■■ Support de révision : il ne remplace pas la formation pratique AFGSU 2, les protocoles du CESU ou ceux de l'établissement.

SOMMAIRE

1. Approche d'une urgence • 2. Évaluation initiale • 3. Alerte • 4. Inconscience • 5. Arrêt cardiaque • 6. Détresse respiratoire • 7. Obstruction • 8. Hémorragie • 9. AVC • 10. Convulsions • 11. Hypoglycémie • 12. Anaphylaxie • 13. Brûlures • 14. Traumatismes • 15. Situations sanitaires exceptionnelles • 16. Les essentiels

1. APPROCHE D'UNE SITUATION D'URGENCE

Sécurité

Conscience

Respiration

Saignement

Alerte

Avant tout geste, vérifier que l'environnement est sûr : risque routier, électrique, incendie, chimique, biologique, etc.

NE JAMAIS DEVENIR UNE DEUXIÈME VICTIME

2. ÉVALUATION INITIALE

Évaluer rapidement la conscience, la respiration, la présence d'une hémorragie grave et les signes de détresse respiratoire ou circulatoire. Réévaluer après toute intervention.

3. ALERTE

NUMÉRO	RÔLE
15	SAMU — urgence médicale
18	Pompiers — secours / incendie
112	Urgence européenne
114	Urgence accessible notamment aux personnes sourdes ou malentendantes

Transmission : où ? quoi ? combien de victimes ? état ? gestes déjà réalisés ? dangers particuliers?

4. INCONSCIENCE



Une personne inconsciente qui respire normalement nécessite une surveillance rapprochée et le maintien de la liberté des voies aériennes. Après recherche d'une contre-indication traumatique, la PLS peut être utilisée.

RÉÉVALUER RÉGULIÈREMENT LA RESPIRATION ET LA CONSCIENCE

5. ARRÊT CARDIAQUE

Reconnaître : inconscience + absence de respiration normale. Une respiration agonique/gasp peut être présente.



♥■ **CENTRE DU THORAX • ZONE DES COMPRESSIONS**

Adulte : 30 compressions / 2 insufflations. Fréquence 100–120/min, profondeur environ 5–6 cm, relâchement complet du thorax et interruptions minimales. Utiliser le DAE dès qu'il est disponible et suivre ses instructions.

■ **DAE : personne ne touche la victime pendant l'analyse et le choc. Reprendre immédiatement la RCP lorsque le DAE le demande.**

6. DÉTRESSE RESPIRATOIRE

Signes : difficulté à respirer, respiration rapide, tirage, cyanose, incapacité à parler normalement, sueurs, agitation, troubles de conscience ou épuisement.

Une détresse respiratoire peut rapidement évoluer vers un arrêt respiratoire puis cardiaque.

Conduite : position la mieux tolérée, souvent assise ; alerte rapide ; surveillance ; paramètres disponibles ; oxygénothérapie selon protocole en vigueur.

7. OBSTRUCTION DES VOIES AÉRIENNES

SITUATION	CONDUITE GÉNÉRALE
Toux efficace	Encourager à tousser et surveiller.
Obstruction sévère	Intervenir rapidement selon les manœuvres enseignées et le protocole en vigueur.
Devient inconsciente	Alerter, débiter la RCP ; rechercher un corps étranger visible sans balayage digital à l'ave

8. HÉMORRAGIE GRAVE

Compression

Pansement

Alerte

Surveillance

Une hémorragie massive peut tuer en quelques minutes. Contrôler immédiatement le saignement. Compression directe si possible ; pansement compressif selon situation ; garrot lorsqu'il est indiqué et que la compression directe n'est pas suffisante ou réalisable. Noter l'heure de pose du garrot.

PRIORITÉ : CONTRÔLER LE SAIGNEMENT. NE PAS PERDRE DE TEMPS AVEC DES GESTES SECONDAIRES.

9. AVC

À rechercher : heure de début des symptômes ou dernière heure connue normale.

F	FACE Asymétrie / paralysie faciale
A	ARM Faiblesse ou paralysie d'un bras
S	SPEECH Trouble brutal de la parole
T	TIME Urgence : noter l'heure et alerter

NE PAS FAIRE : attendre, faire marcher inutilement, donner à boire/à manger ou donner un médicament de sa propre initiative.

10. CONVULSIONS

Pendant la crise : protéger la personne, éloigner les objets dangereux, protéger la tête, ne pas immobiliser brutalement et ne rien mettre dans la bouche. Après la crise : vérifier respiration et conscience, surveiller et rechercher une cause.

11. HYPOGLYCÉMIE

Signes : sueurs, tremblements, faim, confusion, agitation, troubles du comportement ou de conscience.

Si consciente et capable d'avaler : apport de sucre selon protocole.
Si inconsciente : rien par la bouche, sécuriser les voies aériennes, alerter et surveiller.

12. ANAPHYLAXIE

Signes possibles : urticaire, œdème, gêne respiratoire, voix modifiée, gorge serrée, malaise, hypotension ou troubles de conscience.

ANAPHYLAXIE = URGENCE IMMÉDIATE

Alerte immédiate et prise en charge urgente. Si un auto-injecteur d'adrénaline est disponible et indiqué, l'utiliser conformément au protocole et à la formation. Surveillance rapprochée.

13. BRÛLURES

Identifier le mécanisme (thermique, chimique, électrique), l'étendue, la localisation, la profondeur et rechercher une inhalation de fumées. Refroidissement précoce d'une brûlure thermique selon les recommandations/protocoles en vigueur. Ne pas arracher un vêtement collé.

Visage, cou, mains, organes génitaux, grande surface, brûlure circulaire, inhalation de fumées, électrique ou chimique : vigilance particulière.

14. TRAUMATISMES

Priorité aux fonctions vitales. Rechercher hémorragie, détresse respiratoire, trouble de conscience, traumatisme crânien, thoracique ou abdominal et lésions des membres.

Les recommandations françaises 2026 ont actualisé notamment certains points concernant le traumatisé inconscient, le collier cervical et le réalignement de membre. Suivre les recommandations et protocoles enseignés plutôt que des automatismes anciens.

15. SITUATIONS SANITAIRES EXCEPTIONNELLES

NRBC-E	SIGNIFICATION
N	Nucléaire
R	Radiologique
B	Biologique
C	Chimique
E	Explosif

Objectifs : se protéger, protéger les victimes, alerter, organiser, orienter selon les dispositifs prévus, éviter la contamination secondaire et travailler en équipe. Connaître les grands principes ORSAN/ORSEC, tri, damage control et protection NRBC-E.

16. LES ESSENTIELS À MÉMORISER

THÈME	À SAVOIR
Urgence	Protéger → évaluer → alerter → agir → surveiller → transmettre
Arrêt cardiaque	Inconscient + respiration anormale → RCP + DAE
RCP adulte	30/2 ; 100–120/min ; profondeur env. 5–6 cm
Hémorragie	Contrôler immédiatement ; garrot si indiqué
AVC	Déficit brutal → urgence ; noter l'heure ; SAMU
Convulsion	Protéger ; rien dans la bouche ; surveiller
Hypoglycémie	Sucre si conscient/capable d'avaler ; rien par bouche si inconscient
Anaphylaxie	Urgence immédiate ; adrénaline selon indication/protocole
Traumatisme	Priorité aux fonctions vitales
NRBC-E	Protection + alerte + organisation

Références d'actualisation : ANCESU / recommandations nationales SFMU-ANCESU 2026 ; ERC Guidelines 2025 ; HAS, notamment recommandations AVC 2025.

Document de révision — septembre 2026.

AFGSU 2 — COMPLÉMENT 2026

■ Réanimation pédiatrique • Oxygénothérapie • BAVU • Aérosol

Mise à jour : ERC 2025 + référentiel AFGSU/CESU. Les recommandations nationales SFMU-ANCESU 2026 ont également actualisé plusieurs gestes GSU.

1. RÉANIMATION PÉDIATRIQUE

Chez l'enfant, une détresse respiratoire peut évoluer vers l'arrêt cardiaque. La reconnaissance précoce et la ventilation sont donc essentielles. L'ERC 2025 recommande le BAVU avec masque comme première ligne lorsque la ventilation spontanée est insuffisante.

Chez l'enfant qui ne respire pas normalement, les insufflations sont particulièrement importantes. Chez les professionnels formés, utiliser du matériel d'insufflation (BAVU) avec oxygène si possible.

Sécurité

Conscience

Respiration

Alerte

RCP + DAE

RCP pédiatrique : suivre le protocole et l'enseignement pratique du CESU. Utiliser un DAE adapté à l'enfant si disponible. Chez le nourrisson et l'enfant, choisir un matériel et des électrodes adaptés à la taille.

Ventilation : masque de taille adaptée, bonne étanchéité, ouverture correcte des voies aériennes. Insuffler juste assez pour obtenir une élévation thoracique visible. Éviter hyperinflation et pressions excessives.

ERC 2025 — repères pragmatiques de fréquence ventilatoire en ventilation assistée : 25/min chez le nourrisson, 20/min chez l'enfant >1 an, 15/min >8 ans et 10/min >12 ans.

Obstruction : toux efficace → encourager la toux ; obstruction sévère → manœuvres adaptées à l'âge selon la formation ; inconscience → RCP et recherche d'un corps étranger visible, sans balayage digital à l'aveugle.

2. OXYGÉNOTHÉRAPIE

Principaux dispositifs d'oxygénothérapie / ventilation

Lunettes	Masque simple	MHC	BAVU
----------	---------------	-----	------

Le débit doit être adapté au dispositif et à la situation. Chez l'enfant auparavant sain, l'ERC 2025 recommande généralement une SpO₂ cible de 94–98 %, avec la plus faible FiO₂ permettant d'atteindre la cible.

Toujours vérifier le débitmètre, la tubulure, le dispositif, l'étanchéité et la réponse clinique.

Une SpO₂ à 100 % prolongée n'est pas recherchée systématiquement.

3. BAVU

Voies aériennes	Masque adapté	Étanchéité	Insuffler	✓
-----------------	---------------	------------	-----------	---

Le BAVU supplée une ventilation insuffisante ou absente. Chez l'enfant, utiliser un volume adapté et insuffler juste assez pour obtenir une élévation thoracique visible. Une technique à deux personnes peut améliorer l'étanchéité lorsque la ventilation est difficile.

4. AÉROSOL / NÉBULISATION

Préparer

Brancher

Débit matériel

Inhaler



Le gaz propulseur et le débit dépendent du nébuliseur et du protocole. Surveiller FR, travail respiratoire, SpO₂, FC, tolérance et évolution des symptômes. Vérifier le bon fonctionnement et la prescription.

Un aérosol n'est pas simplement « de l'oxygène » : le débit doit correspondre au dispositif utilisé.

OXYGÉNOTHÉRAPIE — DÉBITS À RETENIR

Tableau corrigé selon les valeurs demandées pour le support de révision.

DISPOSITIF	DÉBIT À RETENIR
Lunettes nasales	0,5 à 6 L/min
Masque simple	6 à 9 L/min
Masque haute concentration	9 à 15 L/min
BAVU	15 L/min
Aérosol	Selon le nébuliseur / protocole utilisé

Repère de cours : ces valeurs correspondent au tableau demandé pour ton support. En situation réelle, le débit dépend du dispositif, du patient, de l'objectif de SpO₂, du matériel et du protocole de l'établissement.

Pour le BAVU, le débit retenu dans ce support est 15 L/min. Pour l'aérosol, le débit est à adapter au nébuliseur et à son protocole.